

PROTOCOLO HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA ESTABLE

Unidad de Observación de Media Estancia (UOME)

1. Objetivo

Manejo protocolizado de paciente con hemorragia digestiva alta (HDA) estable, ya valorados en Urgencias y pendientes de realización de endoscopia digestiva alta (EDA) precoz (en las siguientes 24 horas) para confirmación, tratamiento si precisa y decisión posterior de alta o ingreso hospitalario.

2. Definición

La hemorragia digestiva alta (HDA) es el sangrado que se origina en el tracto gastrointestinal proximal al ángulo de Treitz (unión duodenoyeyunal).

Manifestaciones clínicas:

- Hematemesis
- Melenas
- Hematoquecia (si hay sangrado masivo y rápido con afectación del estado hemodinámico)
- Síntomas sistémicos: hipotensión, taquicardia, palidez, síncope

** La prueba de agua oxigenada en heces no tiene valor para la detección de sangre y no debe utilizarse.

3. Valoración inicial

- Evaluación ABCDE, a destacar:

-A: valorar aislamiento de vía aérea si hematemesis masiva, alteración del nivel de conciencia, riesgo elevado de broncoaspiración.

-C: dos vías venosas periféricas de grueso calibre (14-16 G). Extracción de muestras para bioquímica, hemograma, coagulación, grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Monitorización de TA, FC, SatO₂ y diuresis si precisa.

- Medidas generales:

-Fluidoterapia: cristaloides isotónicos. La administración inicial dependerá del estado hemodinámico. Evitar sobrecarga.

-Transfusión de concentrados de hematíes: estrategia restrictiva, si **Hb < 7 g/dL**. Considerar umbral de **8 g/dL** en pacientes con cardiopatía isquémica, enfermedad cardiovascular significativa o shock persistente.

- Tratamiento farmacológico:

-Omeprazol 80 mg en bolo intravenoso (iv), seguido de perfusión continua a 8mg/h o 40mg/12h iv.

-Eritromicina en caso de hematemesis activa o previsión de mala visualización endoscópica. Dosis 250 mg iv diluida en 100 ml de suero fisiológico a pasar en 20-30 minutos, idealmente 30-90 minutos antes de la endoscopia.

-Si sospecha de hemorragia varicosa: somatostatina 250 microgramos en bolo iv, Ceftriaxona 1 gr iv

4. Estratificación del riesgo e indicaciones de endoscopia

Tabla I. Escala de Glasgow-Blatchford. Variables clínicas y analíticas consideradas y puntuaciones para cada uno de sus valores

Marcadores de riesgo a la admisión	Valor en la escala
Urea plasmática (mg/dl)	
≥ 38 < 47	2
≥ 47 < 58	3
≥ 58 < 147	4
≥ 147	6
Hemoglobina (g/dl). Varones	
≥ 12.0 < 13.0	1
≥ 10.0 < 12.0	3
< 10.0	6
Hemoglobina (g/dl). Mujeres	
≥ 10.0 < 12.0	1
< 10.0	6
Tensión arterial sistólica (mmHg)	
100-109	1
90-99	2
< 90	3
Otros marcadores	
Pulso ≥ 100 lpm	1
Presentación con melenas	1
Presentación con síncope	2
Enfermedad hepática previa*	2
Fallo cardíaco**	2

*Historia conocida, o evidencia clínica, analítica, de enfermedad crónica o aguda. **Historia conocida, o evidencia clínica o ecocardiográfica de fallo cardíaco.

Glasgow-Blatchford Score (GBS)

GBS 0-1: riesgo muy bajo, alta desde urgencias con gastroscopia ambulatoria o consulta a Digestivo

GBS 2-5: ingreso en UOME

GBS >5: ingreso en Digestivo

Endoscopia urgente (<12 horas):

- Sospecha de hemorragia por varices gastroesofágicas
- Inestabilidad hemodinámica a pesar de reanimación
- Sangrado activo masivo y/o persistente

Endoscopia precoz (<24 horas):

- Resto de pacientes ingresados

5. Criterios de ingreso en UOME

Deben cumplirse **TODOS**. Los pacientes que no cumplan estos criterios ingresarán en Digestivo o UCI según gravedad.

-HDA de origen no varicoso: quedan excluidos los pacientes con sospecha de sangrado varicoso (antecedentes confirmados de varices esofágicas o sospechar en caso de cirrosis conocida, hipertensión portal, esplenomegalia y ascitis), aunque inicialmente no haya repercusión hemodinámica.

-Sin repercusión hemodinámica: TAS>100 mmHg y mantenida, FC<100 lpm, sin requerimiento de drogas vasoactivas ni necesidad de soporte respiratorio.

-Ausencia de hematemesis activa, sangrado masivo o necesidad transfusional masiva.

-Ausencia de patologías crónicas descompensadas, sepsis, insuficiencia respiratoria grave, coagulopatía grave, mala situación basal, difícil acceso al hospital o escaso apoyo familiar en domicilio.

-Realización de EDA en menos de 24 horas.

** Si la gastroscopia realizada de forma urgente no es concluyente por la presencia de restos de sangre o coágulos que dificultan la visualización correcta del tracto digestivo y como consecuencia el hallazgo de la lesión y su posible tratamiento (suele suceder en lesiones muy tempranas, paciente con escaso periodo de tiempo desde inicio de la clínica), y el paciente cumple criterios de ingreso en la UOME tras la realización de dicha prueba, puede permanecer en dicha unidad a la espera de repetir la endoscopia a ritmo preferente (<24h)

6. Manejo en UOME

- Monitorización:

-TA y FC cada 4 horas.

-Vigilancia de nuevos episodios hemorrágicos.

-Registro de deposiciones.

- Medidas generales:

A. Dieta:

-Dieta absoluta hasta realización de EDA

-En los casos en los que la EDA no sea concluyente y sea necesario repetirla a las 24 horas, deberán permanecer en dieta absoluta.

-Iniciar dieta de ulcus dos horas después de la realización de la endoscopia en pacientes estables con lesiones de bajo riesgo y sin sangrado activo.

B. Sueroterapia.

C. Tratamiento farmacológico:

-Iniciar infusión continua de Omeprazol en dosis de 8mg/h si en la EDA se ha detectado sangrado activo o reciente, ya que reduce sustancialmente el riesgo de resangrado.

- Si no existe sangrado activo o reciente, la infusión de altas dosis de IBP, iniciada antes de la EDA, debe suspenderse.
- Analgesia si precisa: paracetamol 1g intravenoso cada 8 horas.
- Antieméticos si precisa: metoclopramida 10mg/ ondansetrón 4mg intravenosos cada 8 horas
- Analítica de control a las 6 horas, o antes según situación del paciente, si sospecha de sangrado persistente (evitar controles seriados excesivos en pacientes estables)

7. Anticoagulación y antiagregación

A. HDA en pacientes con tratamiento anticoagulante:

• Tratamiento con **dicumarínicos**:

-Si hemorragia activa y niveles supratrapéuticos de INR, se recomienda corrección con vitamina K en dosis de 10mg intravenosa. En caso de inestabilidad hemodinámica también administrar complejo protrombínico. Es aconsejable interconsulta con hematólogo para valorar dosis de complejo protrombínico. Se podría valorar también plasma fresco congelado.

-Si hemorragia activa e INR dentro del rango terapéutico: no hay evidencia sobre la utilidad de corregir la anticoagulación.

• Reintroducción del tratamiento:

• Si riesgo tromboembólico moderado-alto y signos de sangrado reciente: reiniciar antes de los primeros 5-7 días con tratamiento puente con heparina de bajo peso molecular (HBPM).

• Si riesgo tromboembólico bajo o si, independientemente de este riesgo, no hay signos de sangrado reciente, reiniciar tratamiento entre los días 7-15 del episodio hemorrágico con tratamiento puente con HBPM.

• Valorar cambiar dicumarínico por ACOD

• Tratamiento con **anticoagulantes directos (ACOD)**:

-Conocer el momento de la última dosis

-HDA leve: interrumpir ACOD

-HDA moderada-grave: interrumpir ACOD y valorar administrar complejo protrombínico

-Administración de antagonistas: Idarucizumab para Dabigatran; Andexanet alfa para Apixaban y Rivaroxaban.

-Reintroducción del tratamiento: no hay recomendaciones, por lo que parece juicioso actuar como en el caso de los dicumarínicos.

B. HDA en pacientes con tratamiento antiagregante:

-Suspensión transitoria.

-Reintroducción del tratamiento en función de los hallazgos en la EDA y nivel de prevención de riesgo de eventos trombóticos:

a) En prevención primaria siempre interrumpir antiagregación y reevaluar indicación al alta.

b) En prevención secundaria:

•Si Forrest IIc-III en EDA: mantener antiagregación en monoterapia o doble antiagregación.

•Forrest Ia, Ib, IIa, IIb en EDA: en monoterapia, mantener AAS reanudándolo no más allá del tercer al quinto día; en doble antiagregación consensuar estrategia con cardiología, pero, podría mantenerse AAS y suspender el segundo antiagregante reintroduciéndolo preferiblemente antes del 5º día.

8. Criterios de alta tras EDA:

-Estabilidad hemodinámica, sin hematemesis ni nuevas melenas significativas.

-Tolerancia oral.

-Hemoglobina estable.

-Lesión de bajo riesgo (Forrest Iic, III, esofagitis erosiva, gastritis erosiva, duodenitis erosiva, lesión de Mallory-Weiss sin sangrado activo o angiodisplasia tratada sin incidencias)

-Ausencia de enfermedades graves, fácil acceso al hospital y adecuado apoyo familiar en domicilio

9. Recomendaciones al alta

-Dieta blanda o de fácil digestión durante los primeros días, evitando comidas copiosas, grasas, picantes. Comidas frecuentes y poco abundantes.

- Mantener adecuada hidratación.
- Evitar consumo de alcohol y tabaco.
- Reposo relativo las siguientes 24-48 horas
- Seguimiento por Digestivo y/o Atención Primaria. Si se detectó infección por *Helicobacter pylori*, completar tratamiento erradicador y comprobar posteriormente su erradicación según protocolo; revisar resultados de biopsias
- Evitar AINEs
- Antiagregantes y/o anticoagulantes, pautas ya descritas
- IBP según recomendaciones de Digestivo
- Signos de alarma ante los que acudir de nuevo a urgencias:
 - Vómitos con sangre roja o en "posos de café"
 - Heces negras abundantes persistentes o recurrentes
 - Sangrado rectal abundante
 - Mareo intenso, pérdida de conocimiento
 - Palpitaciones
 - Dolor abdominal intenso o progresivo
 - Debilidad marcada o empeoramiento del estado general

10. Bibliografía

10. European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline. Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300-332.
11. American College of Gastroenterology. Laine L, Jensen DM. ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol. 2021.
12. Baveno Consensus Workshop. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959-974.

13. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of portal hypertension. J Hepatol. 2025
14. Stanley AJ, Ashley D, Dalton HR, et al. Outpatient management of patients with low-risk upper gastrointestinal haemorrhage. Lancet. 2009;373:42-47.
15. New England Journal of Medicine. Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368:11-21
16. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Protocolos de manejo inicial, observación e ingreso de pacientes con HDA.
17. Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias Y Emergencias: Guía Diagnóstica Y Protocolos de Actuación. 7a ed. Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L, editores. Elsevier; 2023.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

HEMORRAGIA DIGESTIVA

En un paciente con DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA en una unidad de observación se debe vigilar los signos y síntomas de posibles complicaciones.

Signos y síntomas a vigilar

- **Estado general:**
 - ♣ Fatiga
 - ♣ Ansiedad
 - ♣ Alteración del nivel de conciencia en casos graves.
- **Síntomas asociados:**
 - ♣ Presencia de **náuseas y vómitos**. Aspecto del vómito
 - ♣ **Deposiciones**. Número y características.
 - ♣ **Fiebre**
- **Signos de sangrado:**
 - ♣ Hematemesis (vómito con sangre)
 - ♣ Melena (heces negras, alquitranadas)

- ♣ Rectorragia (sangre roja por recto)
- **Dolor:**
 - ♣ Localización, intensidad, irradiación
 - ♣ Inicio, duración, patrón (cólico, continuo...)
 - ♣ Respuesta a la analgesia.
 - ♣ abundante.

Registros Específicos en la Historia Clínica

- **Valoración del sangrado**
 - ♣ Vómitos de sangre (frecuencia, cantidad, aspecto)
 - ♣ Deposiciones con sangre (frecuencia, aspecto, cantidad)

Signos de alarma

- Signos de shock hipovolémico:
- Hipotensión, taquicardia
- Palidez, sudoración fría
- Alteración del estado mental
- Oliguria (<0,5 ml/kg/h)

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.

4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021. Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025. Mayo Clinic.
10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos